

Task 5: Мієлопатія. Стеноз.(ok)**Відповідальний підрозділ:** Кафедра неврології та нейрохірургії**Автори:**

1. **Солодовнікова Юлія Олександрівна** — розробка завдання , внутрішнє рецензування (відносна частка участі — 50%)
2. **Гнатюк Ірина Михайлівна** — розробка завдання , введення в електронну систему (відносна частка участі — 50%)

Компетенції:**Мета завдання:** Оцінити вміння аналізувати нейровізуалізаційні дані**Обладнання:**

1. Комп'ютер

Витратні матеріали:

Не потрібно

Брифінг

До вас звернулася 47-річна жінка з двохрічною історією болю у шийному відділі хребта, що віддає у руки, слабкості в нижніх та верхніх кінцівках, порушенням ходи, розладами тазових органів.

ok

Текст завдання

Пацієнтка 47-років, скаржиться на біль у шиї, періодичні сильні болі в обох руках і головні болі. Біль у шиї посилюється після фізіотерапії 10 місяців тому. Вона також відзначає поколювання, оніміння та біль, схожий на електричний удар, що іррадіюють в обидві руки, особливо при нахилі голови вперед, зазначає зміни в почерку та погіршення дрібної моторики, а також проблеми з ходом і балансом, через що вона використовує ходунки останні 4 місяці.

У неврологічному статусі: Біль в параспинальних м'язах шиї. Гіпотрофії м'язів верхніх кінцівок. СПР з верхніх кінцівок біцепс, карпорадіальний не викликаються, трицепс жвавий D=S, з нижніх кінцівок високі, з розширенням рефлексогенних зон, клоніод обох стоп. М'язова сила з верхніх кінцівок 3/5 б, з нижніх кінцівок 4/5б. Паталогічні рефлексії: Гофмана двобічно, Бабінського двобічно.

1. Уточнити скарги, анамнез хвороби, анамнез життя.
2. Поставити попередній діагноз, призначити необхідний метод нейровізуалізації (вказати відділи).
3. Інтерпретувати результати нейровізуалізації.

ok

Conditionally displayed materials:

1. Підзавдання - тригер: №5 (-Вказати зміни на наданих зрізах МРТ шийного відділу хребта (центральна кила диску, стеноз спинномозкового каналу, мієлопатія (компресія спинного мозку, гіперінтенсивний сигнал в зоні компресії))

2. Підзавдання - тригер: №5 (-Вказати зміни на наданих зрізах МРТ шийного відділу хребта (центральна кила диску, стеноз спинномозкового каналу, мієлопатія (компресія спинного мозку, гіперінтенсивний сигнал в зоні компресії))

Чеклист

1. -Привітатися, представитися, запитати як може звертатися до пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
2. -Ознайомитися з наявними даними, уточнити скарги у пацієнта Значення: 2%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
3. -Встановити синдромальний діагноз Значення: 10%	

☐ Не виконано	☐ Виконано
4. -Обґрунтувати необхідність проведення нейровізуалізації Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
5. -Призначити МРТ шийного відділу хребта Значення: 11%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
6. -Вказати зміни на наданих зрізах МРТ шийного відділу хребта (центральна кила диску, стеноз спинномозкового каналу, мієлопатія (компресія спинного мозку, гіперінтенсивний сигнал в зоні компресії) Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
7. -Вказати рівень ураження (кила C5-C6, сегмент C7) Значення: 20%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
8. -Встановити діагноз Значення: 15%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
9. -Призначити консультацію суміжного спеціаліста Значення: 10%	
☐ Не виконано	☐ Виконано
10. -Вказати подальшу тактику ведення пацієнта, перерахувати варіанти лікування Значення: 5%	
☐ Не виконано	☐ Виконано

Інструкції для актора

Лікар (студент)	Пацієнтка (акторка)
Добрий день, мене звати (ім'я), я лікар невропатолог, як я можу до вас звертатися? Що вас турбує?	Добрий день, лікарю.мене звати Інна. У мене болить шия, часто болять обидві руки, і з'явилися головні болі.
Скільки часу ви це відчуваєте?	Болі були давно, але після фізіотерапії, вправлення хребців 10 місяців тому стало гірше.
Який характер болю?	У шії — постійний тягнучий, скутість, у руках — різкий, як удар струмом, ще буває оніміння, поколювання повзання мурах.
Що провокує або посилює симптоми?	Особливо коли нахиляю голову вперед, коли довго стою
Чи змінилась сила в руках або ногах?	Так, руки стали слабші, іноді важко щось втримати. Ноги теж наче ватні, ледве хожу.
Як ви зараз пересуваєтесь?	Вже чотири місяці ходжу з ходунками.
Чи змінилась функція тазових органів — сечовипускання, дефекація?	Так, важко контролювати, бувають несподівані позиви.
Згідно вашого неврологічного огляду я підозрюю у вас ураження спинного мозку. Для більш точного діагнозу необхідно виконати МРТ шийного відділу хребта (Дивиться на знімки МРТ, які з'являються на моніторі)	Так, звичайно.
Бачимо грижу між хребцями C5–C6, яка стискає спинний мозок. Є ознаки мієломаляції — тобто ураження речовини спинного мозку.	—
Уу вас шийна мієлопатія. Необхідна консультація нейрохірурга — можливо, буде потрібна операція.	Це серйозно?
	Я зрозуміла. Дякую вам.

ok